

CAPÍTULO 8.12

Daño Hepático Crónico

PERFIL EUNACOM 1.06.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Daño Hepático Crónico (Cirrosis)

Causas

- **Alcohol** (principal en Chile, las 3 primeras causas)
- NASH (esteatohepatitis no alcohólica)
- Hepatitis crónicas (VHB, VHC)
- Colestasias crónicas (CBP, CEP)

Complicaciones — Marco Organizador

''' Daño Hepático Crónico | Hipertensión Portal | Várices esofágicas | Ascitis | Síndrome hepatorenal (también relacionado a ascitis) | Insuficiencia Hepática | Encefalopatía hepática | Coagulopatía hepática '''

1. Várices Esofágicas

Escenario A: Várices asintomáticas (hallazgo en endoscopia de control)

> Todo cirrótico debe hacerse endoscopia de control al menos 1 vez/año.

TABLA 8.12.1: SITUACIÓN VS PROFILAXIS

SITUACIÓN	PROFILAXIS
Primaria (nunca sangró)	Propranolol VO ajustado a FC 55-60 lpm
Contraindicación a propranolol (EPOC, asma)	Ligadura endoscópica
Secundaria (sangró antes)	Propranolol + ligadura endoscópica

PERLA CLÍNICA EUNACOM

¿Cuándo propranolol? **Siempre**. ¿Cuándo ligadura? Cuando ya sangró o hay contraindicación a propranolol.

Escenario B: Hemorragia variceal activa (urgencia)

- **Suero fisiológico EV** (reposición de volemia)
- **Endoscopia de urgencia** (ligadura o escleroterapia)
- **Terlipresina EV** (vasoconstrictor — elección para sangrado variceal)
- - Alternativa si no disponible: Octreótide (análogo somatostatina, eficacia menor)
- **Tiamina EV** si paciente alcohólico (profilaxis encefalopatía de Wernicke)
- **Antibióticos EV** si tiene ascitis (profilaxis peritonitis bacteriana espontánea)
- Una vez estabilizado → **profilaxis secundaria** (propranolol + ligadura)

Cuando falla todo: TIPS

- **TIPS** (shunt portosistémico transyugular intrahepático) → última línea en:
- Hemorragia variceal refractaria a profilaxis secundaria
- Ascitis refractaria

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

TIPS contraindicado con **encefalopatía hepática** (incluso leve), porque al desviar sangre fuera del hígado aumenta las toxinas que llegan al cerebro → empeora la encefalopatía → coma.

2. Ascitis

Diagnóstico Clínico

- Aumento del perímetro abdominal

- Matidez desplazable
- Signo de la ola
- Confirmación con **ecografía** si hay duda

Tratamiento según tipo

TABLA 8.12.2: TIPO DE ASCITIS VS TRATAMIENTO

TIPO DE ASCITIS	TRATAMIENTO	
Simple / no complicada	Diuréticos: espironolactona (primera línea) ± furosemida	Restricción hidrosalina
A tensión (piel del abdomen muy tensa, dolorosa)	Paracentesis evacuadora + albumina 8 g/L extraído	
Refractaria (no responde a diuréticos)	Paracentesis periódicas + albumina; considerar TIPS o trasplante	

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Dosis máx de diuréticos: espironolactona 400 mg/día + furosemida 160 mg/día.

EUNACOM CRITERIOS

ANTES de toda paracentesis evacuadora de ascitis a tensión: hacer **paracentesis diagnóstica** para descartar PBE (peritonitis bacteriana espontánea). Si se drena una PBE sin tratarla primero → el paciente puede morir.

3. Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE)

Indicación de paracentesis diagnóstica

Todo cirrótico descompensado con ascitis que llega a urgencia → paracentesis diagnóstica obligatoria.

Diagnóstico

- PMN (polimorfonucleares) en líquido ascítico $\geq 250 / \text{mm}^3$
- Predominio polimorfonuclear (si fuera mononuclear → pensar en TBC o carcinomatosis peritoneal)

Tratamiento

- **Cefotaxima EV** 7 días (no ampicilina → metabolismo hepático; cefotaxima es excreción renal)
- **Albúmina EV:** 1,5 g/kg día 1 + 1 g/kg día 3 → profilaxis del síndrome hepatorenal

Profilaxis de PBE (antibióticos a largo plazo)

TABLA 8.12.3: INDICACIÓN VS TIPO

INDICACIÓN	TIPO
Después de una PBE	Profilaxis secundaria (siempre, mientras tenga ascitis)
Hemorragia digestiva alta con ascitis	Profilaxis primaria
Albúmina en líquido ascítico < 1,5 g/dL	Profilaxis primaria

- Antibiótico de profilaxis: **Ciprofloxacino** VO (o quinolona alternativa, o cotrimoxazol) - Agente causal más frecuente: **E. coli** y gram negativos intestinales

Albumina en líquido ascítico — 2 usos

- **Gradiente de albúmina sérica-ascítica** > 1,1 g/dL → la causa de la ascitis es **hipertensión portal**

- **Albumina en ascitis < 1,5 g/dL** → indicación de profilaxis primaria de PBE (riesgo de infección aumentado)

4. Síndrome Hepatorrenal (SHR)

- **Insuficiencia renal aguda** prerenal en contexto de daño hepático crónico (cirrosis)
- Pronóstico muy malo (semanas/meses de vida)
- Descartar otras causas de IRA: sedimento de orina (infección, glomerulonefritis), ecografía renal (obstrucción)
- **Tratamiento:**
 - 1. **Trasplante hepático** (único definitivo)
 - 2. **Terlipresina EV** (vasoconstrictora, prolonga la vida mientras espera trasplante)
 - 3. Albumina + manejo de ascitis refractaria

Síndrome Hepatopulmonar (diferente del hepatorrenal)

- **Ortodeoxia:** desaturación al estar de **pie** → mejora al acostarse (opuesto a la ortopnea)
- Marcador de daño hepático crónico grave
- No confundir con hepatorrenal

5. Encefalopatía Hepática

- **Causa:** el hígado no filtra toxinas intestinales → acumulación en sangre → cerebro
- **Clínica:** desorientación, compromiso de conciencia, **asterixis** (flapping tremor = marcador de encefalopatía metabólica)
- **Diagnóstico:** clínico (en contexto de cirrótico)
- **Precipitante más frecuente:** infecciones

Tratamiento

- **Buscar y tratar la causa descompensante** (infección, hemorragia, fármacos)
- **Lactulosa** (laxante osmótico): dosis ajustada para 2-3 deposiciones blandas/día
 - - Inicio: 15 cc c/8 h → ajustar
 - - Si hace 1 deposición/día → subir dosis Si hace diarrea → bajar dosis

6. Coagulopatía Hepática

- El hígado sintetiza factores de la coagulación → si falla → **↑ TP/INR**
- Esplenomegalia → secuestro de plaquetas → **trombocitopenia**
- Resultado: hemostasia primaria Y secundaria alteradas → alto riesgo de hemorragia

Tratamiento

- **Plaquetas < 50.000/mm³** → transfusión de plaquetas
- **TP muy alterado** → crioprecipitado o plasma fresco congelado
- **Mismos precipitantes:** infecciones → buscar y tratar siempre

Resumen de Descompensantes del Cirrótico

- Las **infecciones** son la causa descompensante más frecuente de:
- Encefalopatía hepática
- Coagulopatía
- Ascitis a tensión
- PBE

→ Siempre buscar foco infeccioso en el cirrótico descompensado (orina, sangre, líquido ascítico)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 60 años con cirrosis hepática Child-Pugh C consulta por aumento de volumen abdominal y dolor sordo difuso. Examen: ascitis a tensión y dolor a la palpación abdominal. Se realiza paracentesis diagnóstica: líquido turbio con recuento de Leucocitos de 850/mm³ y 72% de Polimorfonucleares (PMN = 612/mm³). Gradiente albúmina suero-ascitis (GASA): 1.6 g/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE): definida por recuento de Polimorfonucleares (PMN) en líquido ascítico $\geq 250/\text{mm}^3$, independiente del cultivo. Germen más frecuente: E. coli y Klebsiella. Tratamiento urgente: Ceftriaxona 2g EV/día por 5 días + Albúmina humana EV (1.5 g/kg el día 1 y 1.0 g/kg el día 3, para prevenir el síndrome hepatorrenal y reducir la mortalidad). Profilaxis secundaria de por vida con Ciprofloxacino o Norfloxacino.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa principal de DHC: alcohol; complicaciones de HTP (várices, ascitis) y de insuficiencia hepática (encefalopatía, coagulopatía)
- Várices: profilaxis primaria = propranolol; secundaria = ligadura + propranolol; hemorragia activa = suero + endoscopia + terlipresina
- Ascitis: diuréticos (espironolactona > furosemida); a tensión: descartar PBE primero, luego paracentesis + albúmina
- PBE: >250 PMN/mm³; tratamiento con cefotaxima IV 7 días + albúmina profiláctica
- Todo cirrótico descompensado con ascitis → paracentesis diagnóstica como primer examen
- Encefalopatía: buscar descompensante (infecciones) + lactulosa ajustada a 2-3 deposiciones/día
- TIPS: indicado en várices refractarias y ascitis refractaria; CONTRAINDICADO en encefalopatía
- Síndrome hepatorrenal: pronóstico muy malo; terlipresina + trasplante

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO)

PREGUNTA 1

Paciente cirrótico con ascitis a tensión. ¿Cuál es la primera conducta antes de realizar la paracentesis evacuadora?

- A) Iniciar espironolactona
- B) Realizar paracentesis diagnóstica para descartar PBE
- C) Administrar albúmina endovenosa
- D) Instalar TIPS
- E) Iniciar cefotaxima empírica

PREGUNTA 2

Paciente con daño hepático crónico y várices esofágicas asintomáticas encontradas en endoscopia de control. Nunca ha sangrado. ¿Cuál es la profilaxis indicada?

- A) Ligadura endoscópica + propranolol
- B) Propranolol oral
- C) TIPS
- D) Terlipresina endovenosa
- E) Escleroterapia endoscópica

PREGUNTA 3

Paciente cirrótico con encefalopatía hepática y ascitis refractaria. Se propone instalación de TIPS. ¿Cuál es su opinión?

- A) Indicado para manejar ambas complicaciones
- B) Contraindicado por la encefalopatía
- C) Indicado solo si la ascitis no responde a diuréticos
- D) Indicado si se agrega lactulosa profiláctica
- E) Indicado si se agrega rifaximina

RESUMEN: DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO

Clase sobre daño hepático crónico y sus complicaciones. Causa principal: alcohol; luego hepatitis crónicas y colestasias crónicas. Complicaciones de hipertensión portal: várices esofágicas (profilaxis primaria con propranolol, secundaria con ligadura + propranolol) y ascitis. Complicaciones de insuficiencia hepática: encefalopatía (lactulosa) y coagulopatía. Ascitis: diuréticos (espironolactona + furosemda); a tensión: paracentesis evacuadora + albúmina; refractaria: TIPS o trasplante. PBE: >250 PMN/mm³, cefotaxima IV 7 días + albúmina. El TIPS está contraindicado en encefalopatía. Síndrome hepatorenal: pronóstico muy malo, terlipresina + trasplante.